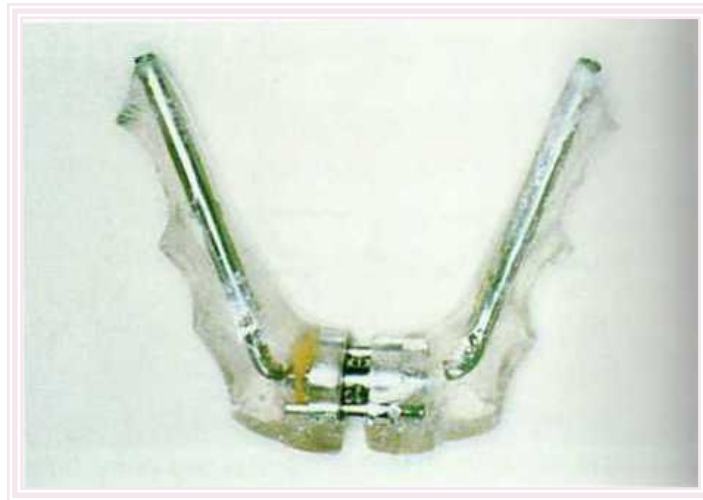
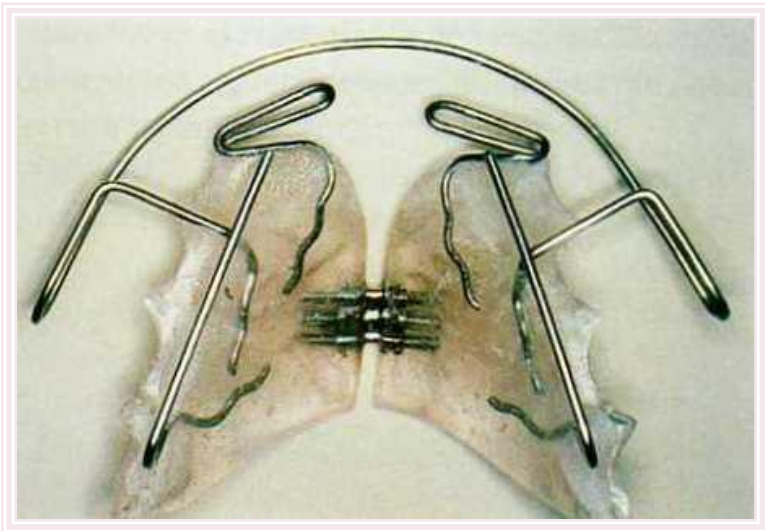


SIMONES NETWORK



- Simoes Network es un aparato de ortopedia funcional perteneciente al grupo de los híbridos, el cual surge de la combinación de la filosofía de otros dos aparatos, el Bimler y las Placas Planas

**“El objetivo principal es resolver problemas en
los cuales otros aparatos fracasan,
principalmente en las primeras etapas del
desarrollo ontogénico, debido a que favorecen
más que otros el control de la trayectoria de
erupción”**

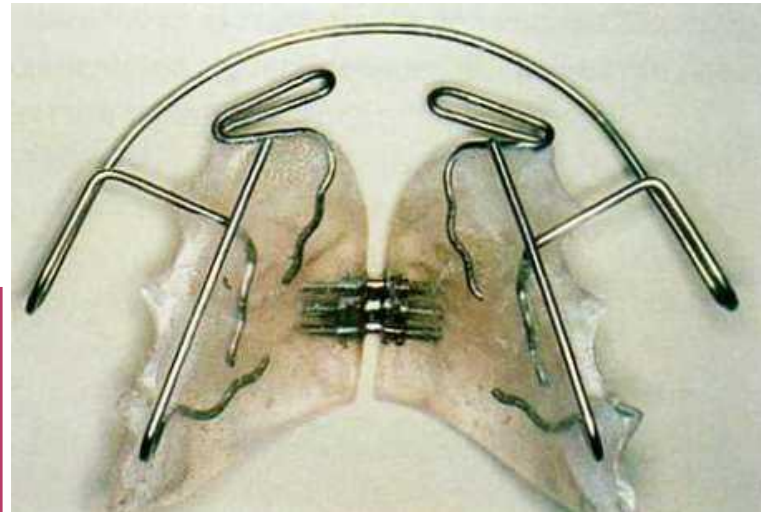
MODELOS SIMOES NETWORK, SNS.

- ◉ **SN1:** Suave Deslizante (“Slide Light Model”)
- ◉ **SN2:** Mantenedor Lingual (“Tongue Manteiner”)
- ◉ **SN3:** Pequeñas Aletas Inferiores (Lower Winglest Model”)
- ◉ **SN4:** Escudos Laterales y Labiales (“Shield Pad Model”)
- ◉ **SN5:** Conexión Especial en Freno (“Stop Special Model”)
- ◉ **SN6:** Especial de los Escudos Laterales (“Special Pad Model”)
- ◉ **SN7:** En Hebilla (“Clasp Model”)
- ◉ **SN8:** Barra Ondulada Bimaxilar (“Bimaxillary Undulated Bar”)
- ◉ **SN9:** Arcos Dorsales Libres (“Pad-Tie Model”)
- ◉ **SN11:** Aletas Verticales (“Vertical Springs”)

(SN1) SUAVE DESLIZANTE



◉ Usado para neutroclusiones y
Distoclusiones, nunca para mesioclusiones



◉ SE INDICAN PARA:

- ◉ Obtención y manutención del contacto incisivo en Determinada Área D.A
 - ◉ Modificación y manutención del espacio oral funcional
 - ◉ Liberación y ajuste de los movimientos lateroprotrusivos
 - ◉ Anclaje de la postura mandibular con libertad parcial de movimientos
 - ◉ Anclaje de la postura mandibular en prostraslación
 - ◉ Anclaje en la región anteroinferior, independiente de la presencia de los dientes
- ◉ Controlar estímulos específicos en el arco dentario inferior
 - ◉ Distoclusiones
 - ◉ Neutroclusiones
- ◉ Cambio de Postura Terapéutico en 2 etapas.

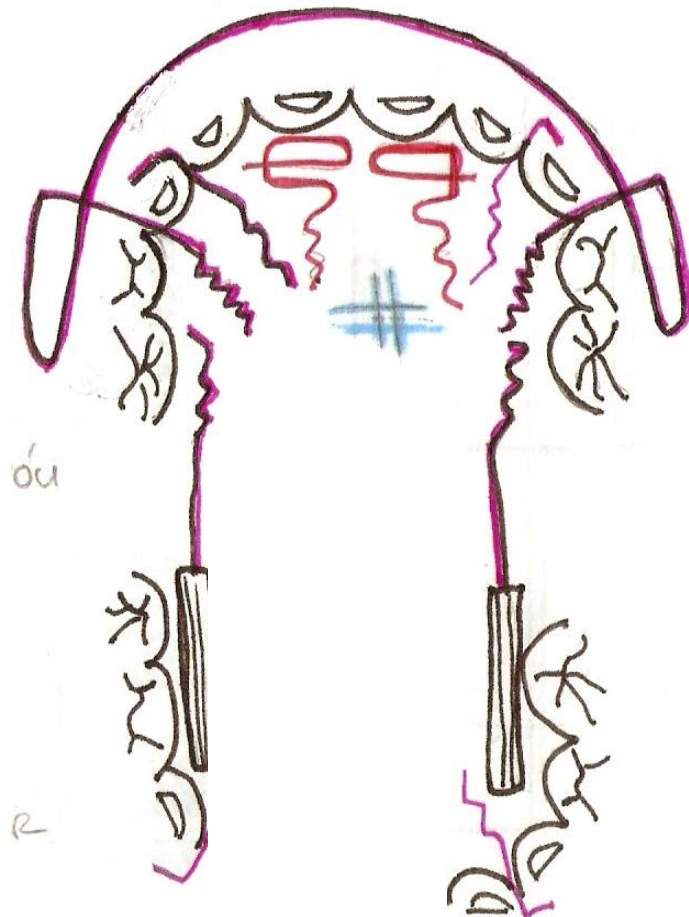
- ◉ El SN1 tiene el anclaje suficiente para actuar en ese periodo, y puede substituirse por AOF-Bimler cuando los incisivos erupcionen y haya anclaje para el complejo Escudo-Corbata que también tiene dificultades para lingualizar incisivos acentuadamente inclinados.

- SN1 es también la alternativa, cuando sea necesaria la colocación de ciertos accesorios de diferentes tipos de arcos vestibulares y de resortes inferiores.

- ◉ Se debe considerar el SN1 con tornillo inferior versus Coffin para el anclaje y el estímulo transversal inferior.
- ◉ La erupción de los premolares inferiores puede guiarse fácilmente con el SN1. Lo mismo se aplica a los segundos molares inferiores permanentes. En ciertos periodos, y dependiendo de cuanto tiempo hace que actúan, los apoyos oclusales de las Pistas Indirectas Planas Simples pueden ser un obstáculo para la erupción de los molares..
- ◉ SN1 puede ser la opción por un periodo para superar esas dificultades.

ELEMENTOS

- ◉ Arco de Bimler
- ◉ Muelles Frontales
- ◉ Estabilizadores en caninos
Sup e inf (opcionales)
- ◉ Tornillo de expansión
Superior e inferior
- ◉ Tubos telescópicos
- ◉ Arcos dorsales
- ◉ Bases acrílicas



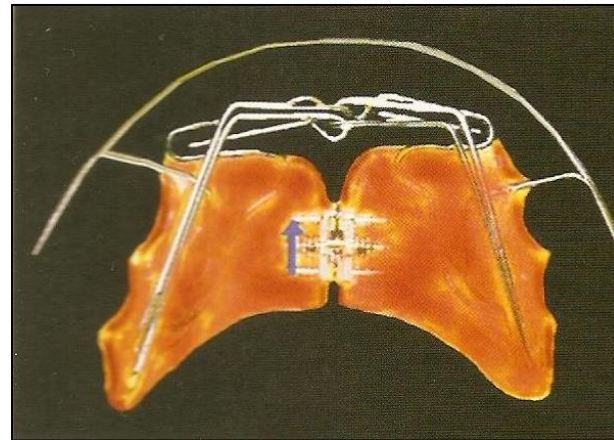
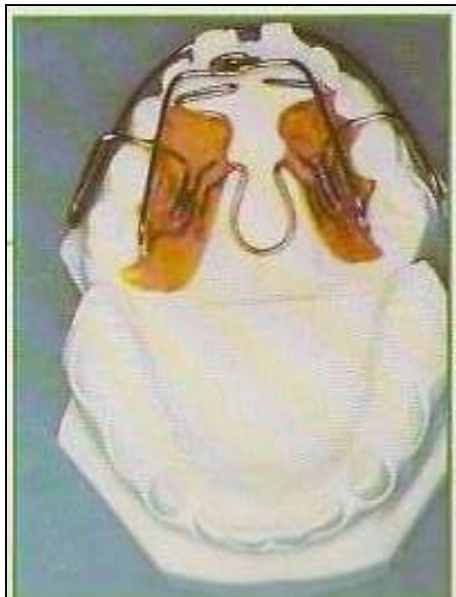
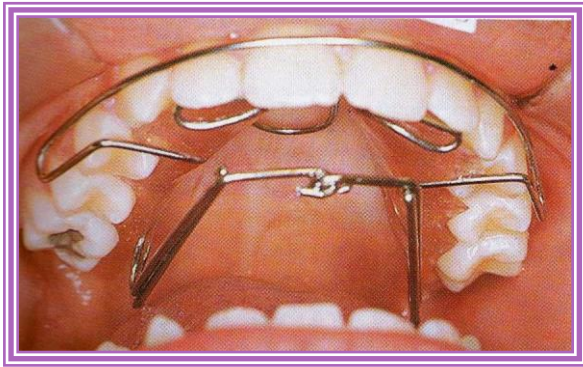


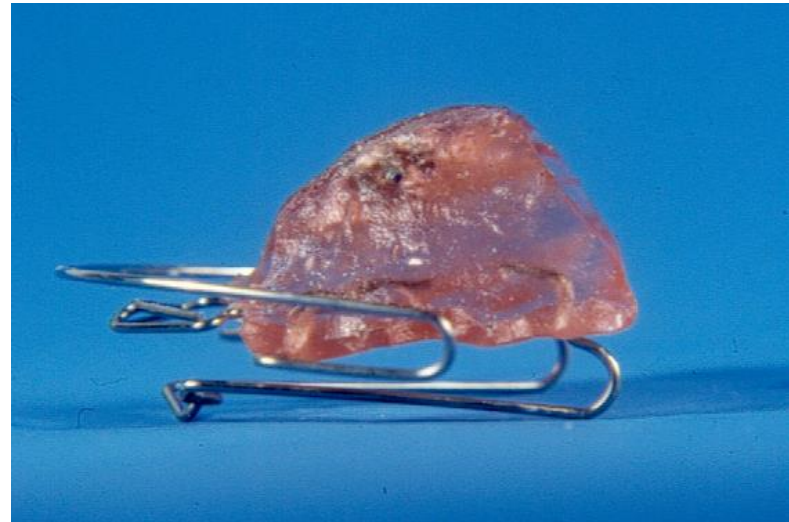
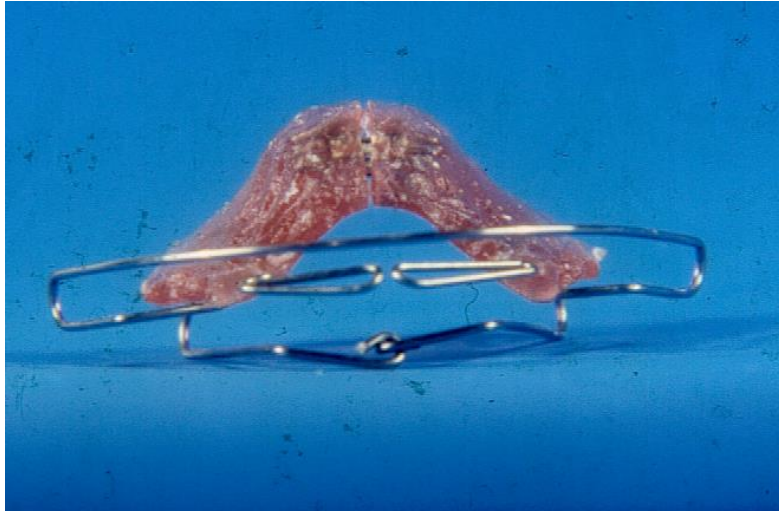
(SN 2)
MANTENEDOR LINGUAL



INDICACIONES:

- ◉ Neutroclusiones, mesio-clusiones, mordidas abiertas o mordidas cruzadas, tendencia progenie, borde a borde, biprotrusión, disto-oclusión o diastemas
- ◉ Orientar la posición fronto sagital de la lengua en mordidas cruzadas.
- ◉ Controlar la posición del hueso hioides en la oclusopatía borde a borde.
 - ◉ Controlar la acción de la lengua muy espesa.
 - ◉ Eliminar la concavidad del dorso de la lengua.
- ◉ Orientar la posición sagital mandibular derecha e izquierda.
 - ◉ Anclar la postura sagital mandibular



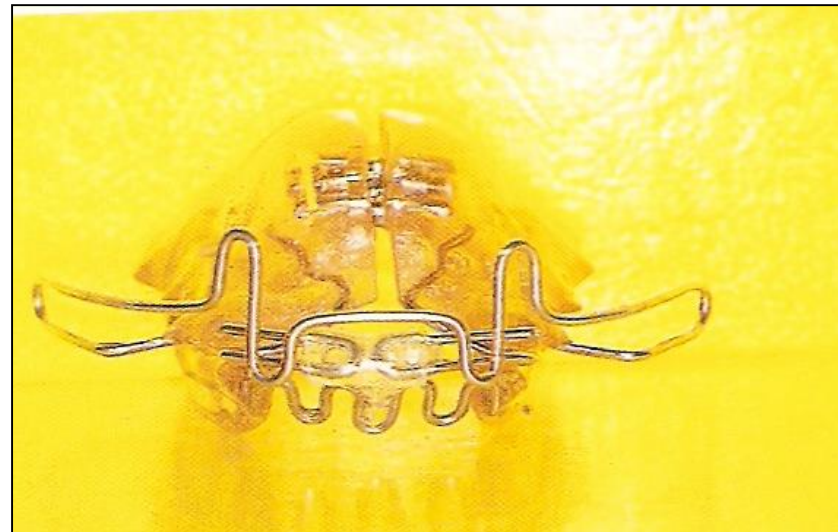
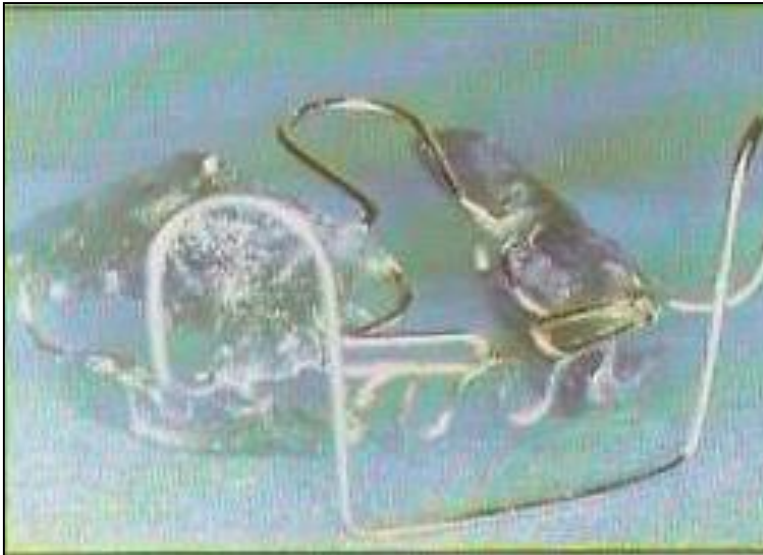


(SN3)
PEQUEÑAS ALETAS
INFERIORES



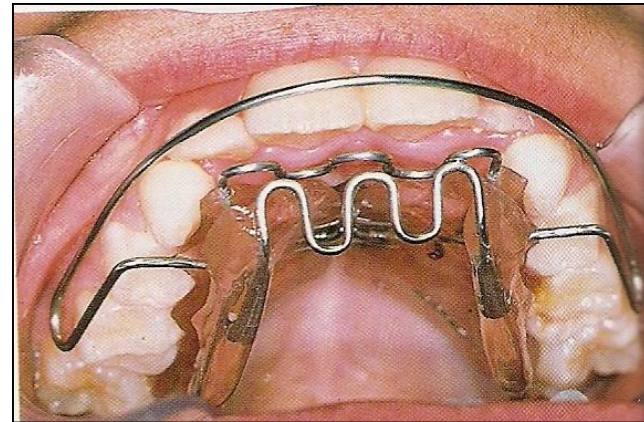
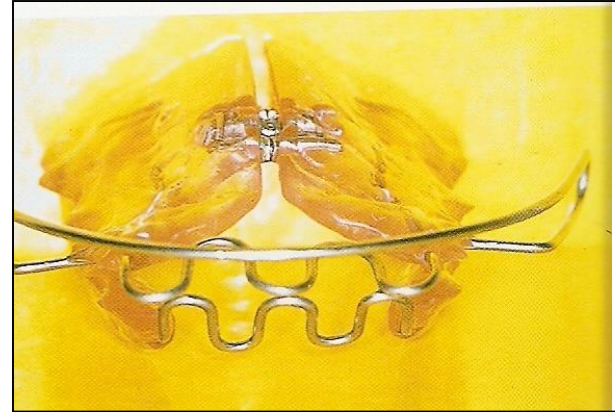
CONSIDERACIONES DEL SN3

- ◉ La acción sobre la lengua es menos intensa
- ◉ Tiene una capacidad estructural para anclar la mandíbula por medio de poco contacto con las estructuras orales



INDICACIONES

- ◉ Plano Oclusal divergente, mordida abierta, mordida cruzada, mesioclusión, tendencia de progenie, tope a tope, biprotrusión y distoclusión
- ◉ Controlar el desarrollo de los arcos dentarios, en clase III, y en clase I (pseudos Clase III) o ligera mesioclusión.



OBJETIVOS

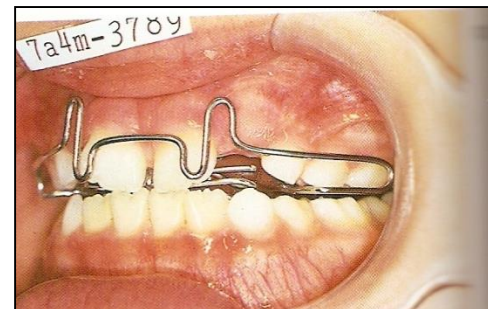
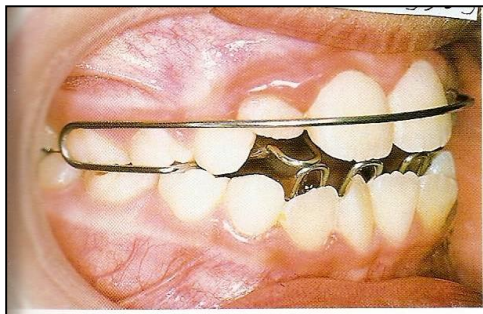
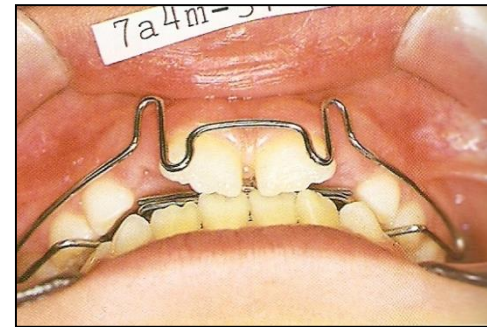
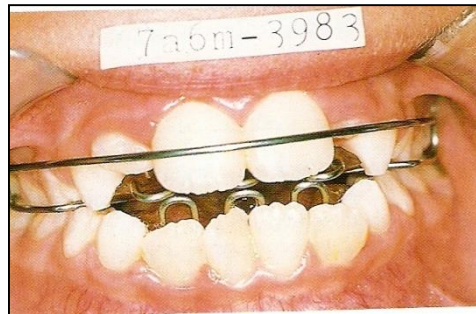
- ◉ Estimular desarrollo mandibular
- ◉ Anclar la postura mandibular retro directa, sin rotación aparente.
 - ◉ Cambio de postura terapéutico en dos etapas.
 - ◉ Aumentar el espacio oral funcional.
- ◉ Cambiar la posición de la lengua variando la posición mandibular
 - ◉ Ampliar los movimientos latero-protrusivos.

ELEMENTOS

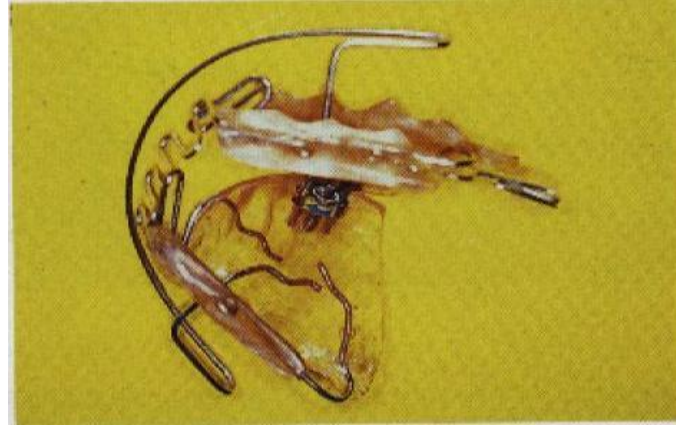
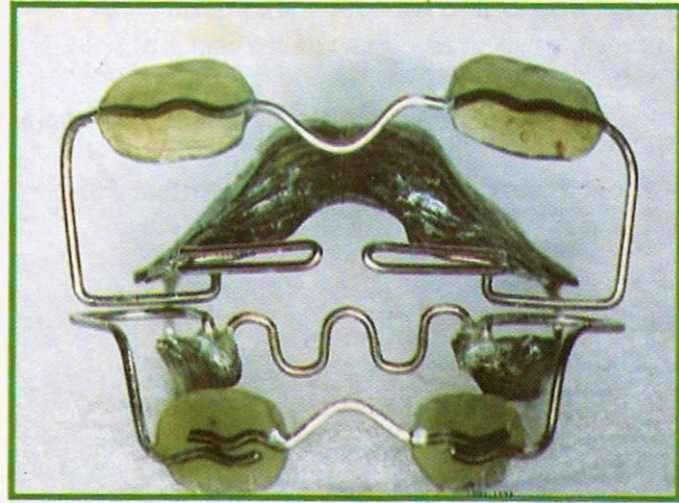
- ◉ Arco vestibular o arco de Eschler
- ◉ Arco vestibular ondulante de impulso
- ◉ Tornillo ó Coffin
- ◉ Muelles frontales
- ◉ Barra ondulada
- ◉ Bases acrílicas





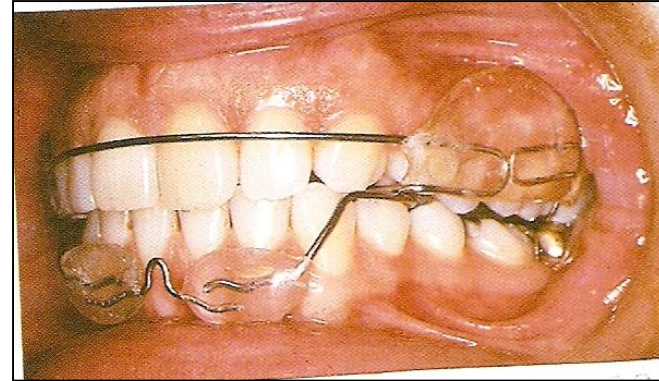
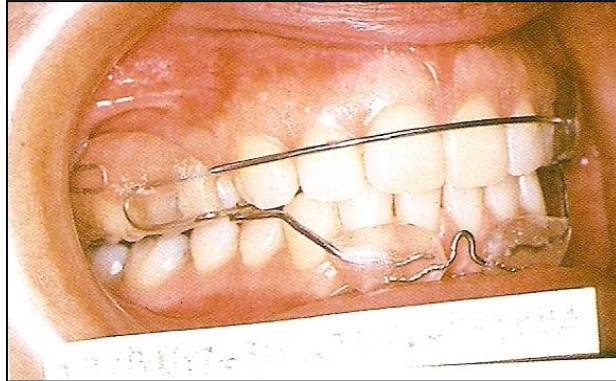






(SN4)
ESCUDOS LATERALES
LABIALES





- ◉ Muy eficaz para adultos
- ◉ Este aparato tiende a lastimar y su adaptación es difícil, haciendo necesario más anclaje del que el SN4 puede ofrecer bioplásticamente

INDICACIONES

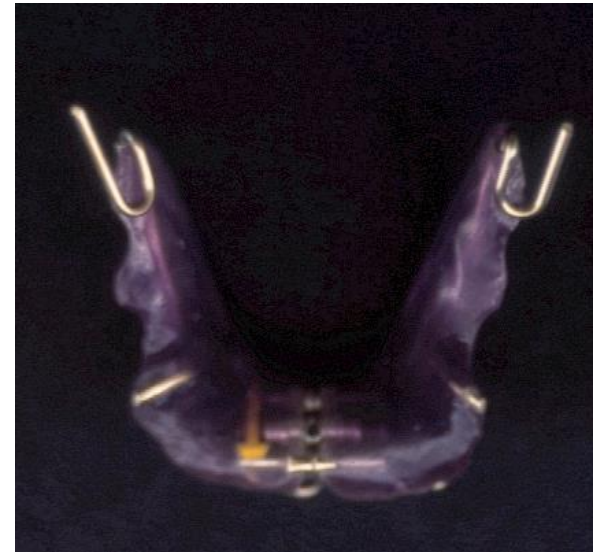
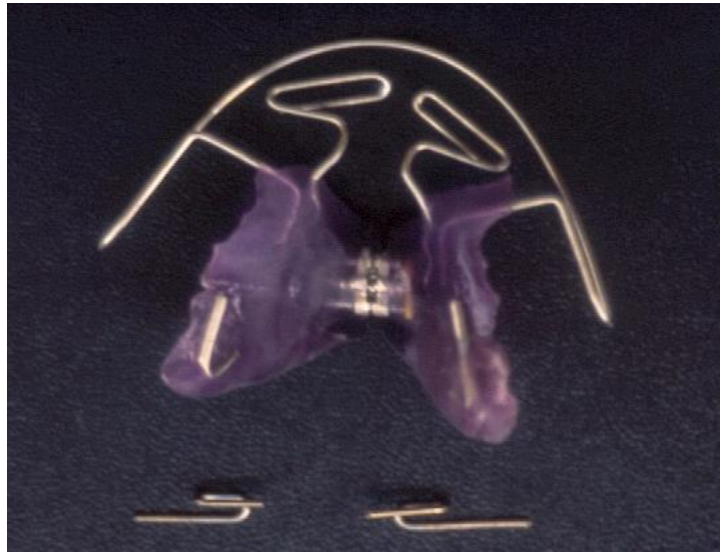
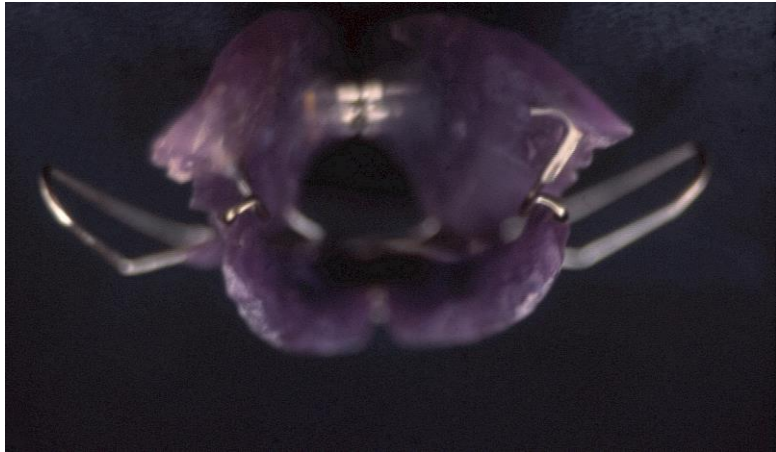
- ◉ Se usa en distoclusiones, mordidas cruzadas, mesioclusiones, tope a tope
- ◉ Anclaje bimaxilar de distoclusiones (escudos labiales inferiores y/o laterales).
 - ◉ Estimular el cierre de la boca
- ◉ Anclaje bimaxilar de maloclusiones, tendencias de proyección tope a tope (escudos labiales superiores y/o laterales).
- ◉ Anclaje maxilar de mordidas cruzadas unilaterales o bilaterales.
- ◉ Modificar y controlar la postura del sobre facial.

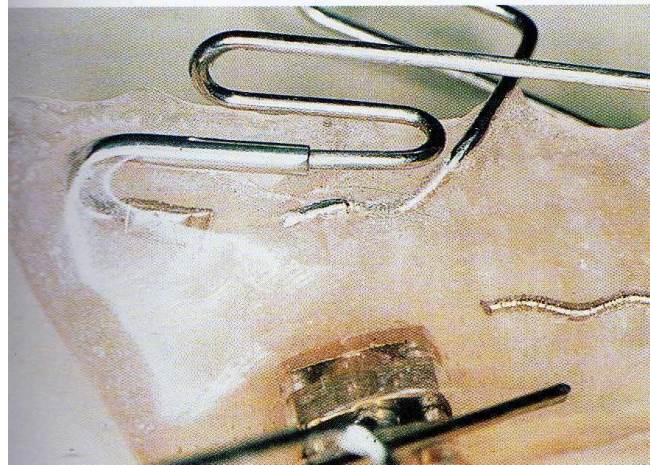
ELEMENTOS

- ◉ Escudos labiales en anteroinferiores a nivel de 1/3 gingival de la corona clínica
 - ◉ Escudos laterales
- ◉ Arco vestibular con ansa a nivel de molares
 - ◉ Bases acrílicas

(SN 5)
CONEXIÓN ESPECIAL
EN FRENO

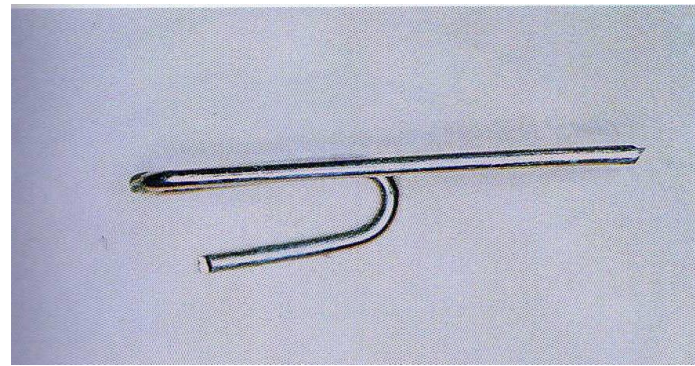






- ◉ Raramente usados.
- ◉ Indispensable parte superior del aparato por perdidas dentarias “accidentes” porque tiene dientes artificiales acoplados para ser usados en la masticación.

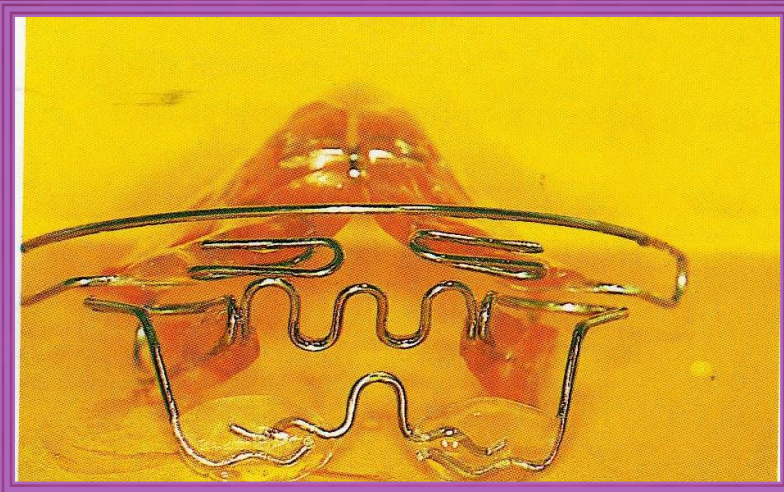
- ◉ Durante la alimentación, se desengancha en la parte inferior.
- ◉ Recurso especial que impide que la mandíbula pierda el contacto incisivo en determinada área, frenándola en posición mas avanzada.
- ◉ La conexión en freno puede usarse en cualquier tipo de aparato de arcos dorsales, que se cambia fácilmente en la clínica.
- ◉ Los tubos tienen 10mm fuera delacrílico para recibir los arcos dorsales y 10mm de retención.
- ◉ Los alambres 0,9 se doblan en planos perpendiculares. El encaje de ambos forma una articulación.



INDICACIONES

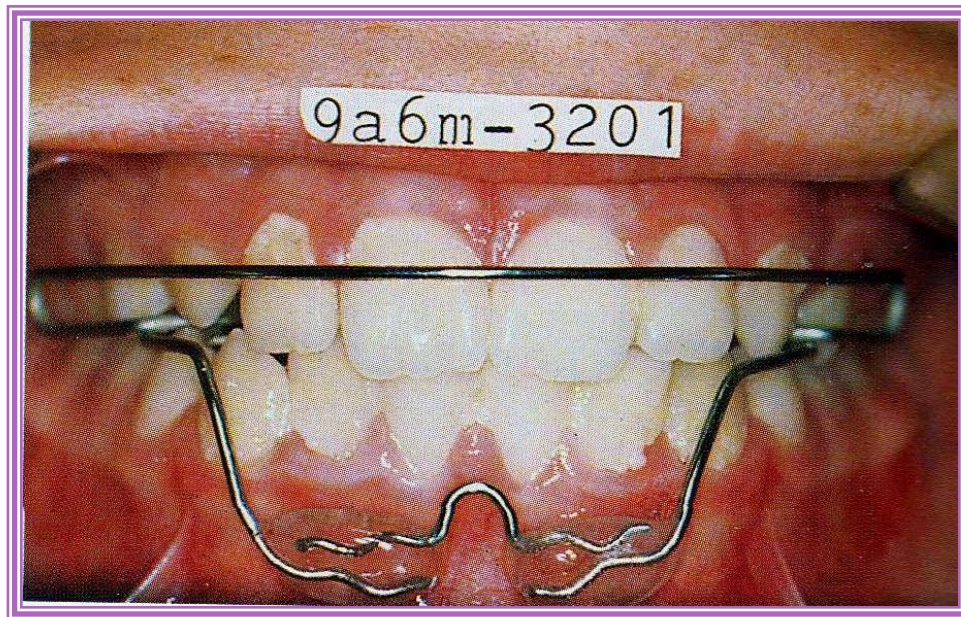
- ◉ Manejar el cambio de postura terapéutico.
- ◉ Evitar fracturas repetidas de los Arcos Dorsales.
- ◉ Mantener una de las partes para mas eficacia masticatoria “perdidas dentarias”.
- ◉ Ampliar los movimientos latero-protrusivos.
- ◉ Obtención y manutención del contacto incisivo en Determinada Área.

(SN 6)
ESPECIAL DE LOS
ESCUDOS LATERALES

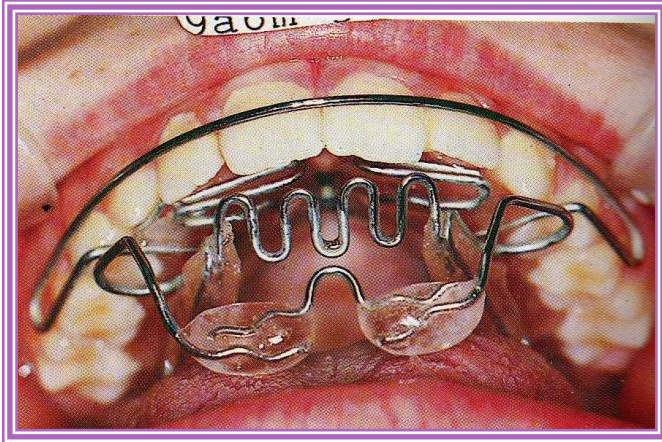
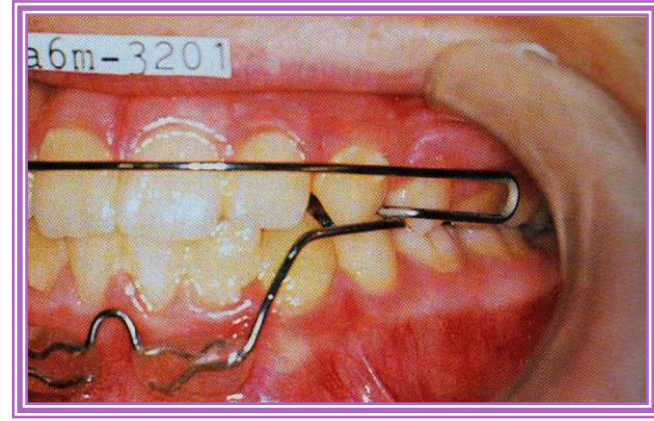
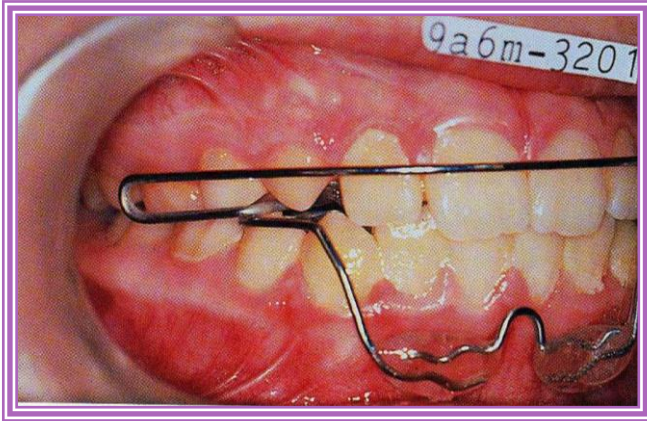


USOS

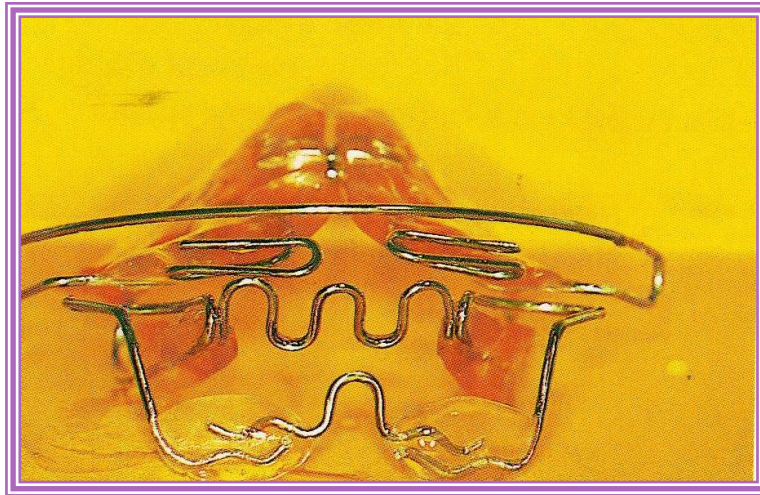
- Se usa para cambio de postura terapéutico sagital con rotación predominante y translación.



- ◉ Los elementos anteriores, frontales superiores e inferiores deben estar ubicados por el análisis de localización del compas articular.
- ◉ Contraindicados en dentición decidua y para tratamiento de mesioclusión, tendencia de progenie o tope a tope.
- ◉ Las Curvas Posteriores de los Arcos Dorsales deben estar entre 1 y 3 mm más debajo de los cuellos. Así se compensa con la rotación anterior de la mandíbula, provocada por la estructura del aparato que hace bajar la mandíbula en la región de molares y subir los incisivos.
- ◉ Resiste el movimiento inducido por el aparato y rueda al contrario de cómo lo hacia cuando se coloco en boca.
- ◉ Las dos curvas posteriores de los arcos dorsales suben y permanecen a la altura de los cuellos gingivales o si fuesen estos irregulares, a la altura media.



- Los escudos labiales y la pieza de unión entre ellos siempre en posición vertical y bajos para anclar la mandíbula y suministrar estímulos apropiados a los tejidos blandos.
- Los escudos labiales importantes para el anclaje del aparato.



- ◉ Cuando el SN6 es colocado en boca, inicialmente gira en sentido contrario a las manecillas del reloj con relación a la mandíbula.
- ◉ Esta lo sigue, pero después no lo logra mas por causa de la postura la cual es completamente nueva, por eso la mandíbula se resiste.
- ◉ El aparato comienza a ceder y es él el que comienza a girar suavemente en el sentido horario.

INDICACIONES

- ◉ para pacientes con perfiles muy convexos, este actuara favorablemente en la coordinación entre los tres anillos musculares nasal, labial y mentoniano.
 - ◉ Anclaje mandibular bioelástico.
- ◉ Anclar la postura sagital mandibular con prorrotación predominante.
- ◉ Anclar la postura sagital mandibular en rueda, sin translación aparente.
 - ◉ Modificar y controlar la postura labial.
 - ◉ Modificar y controlar la postura del sobre facial.
 - ◉ Cambio de Postura Terapéutica en dos etapas.

(SN 7)
EN HEBILLA

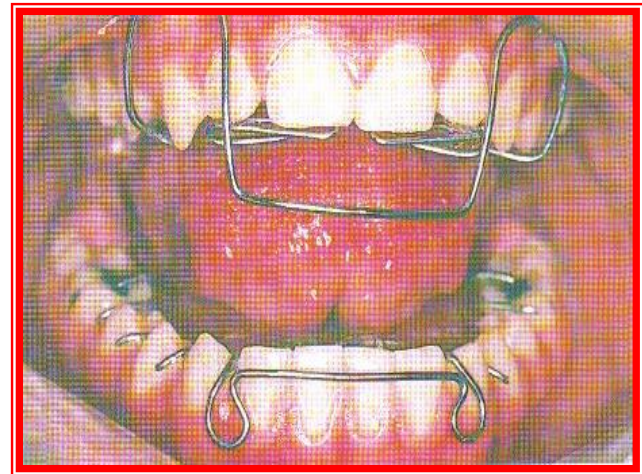






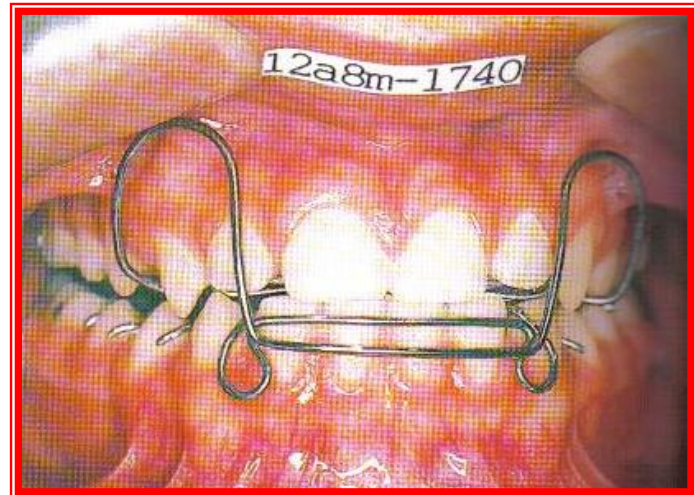
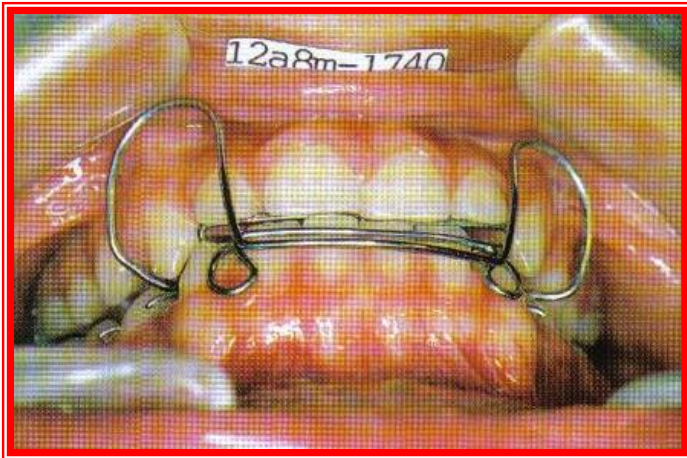
INDICACIONES

- ◉ Controlar posición y crecimiento de la mandíbula en ciertas etapas ontogenéticas
- ◉ Estimular el crecimiento del maxilar en ciertas etapas ontogenéticas
 - ◉ Mesioclusión y tendencia de progenie, con y sin mordida abierta
 - ◉ Borde a borde
- ◉ Obtención y manutención del contacto incisivo .

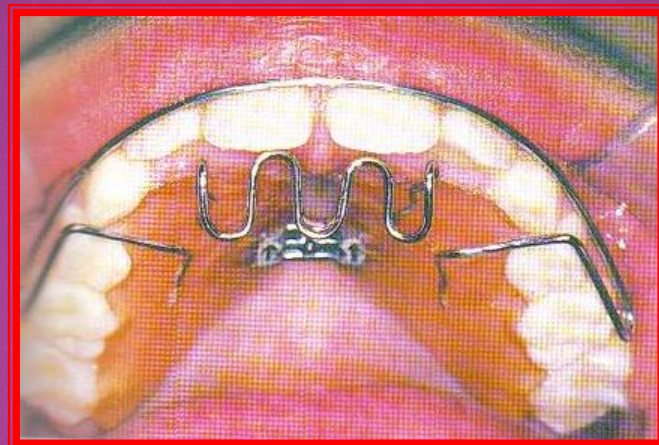


CONTRAINDICACIONES

- ◉ Cuando los incisivos inferiores están muy lingualizados

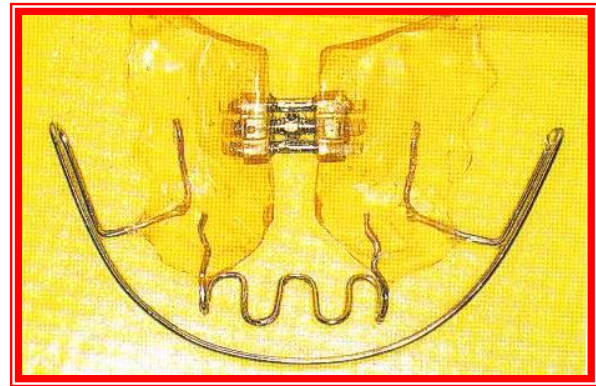


(SN 8)
BARRA ONDULADA
BIMAXILAR



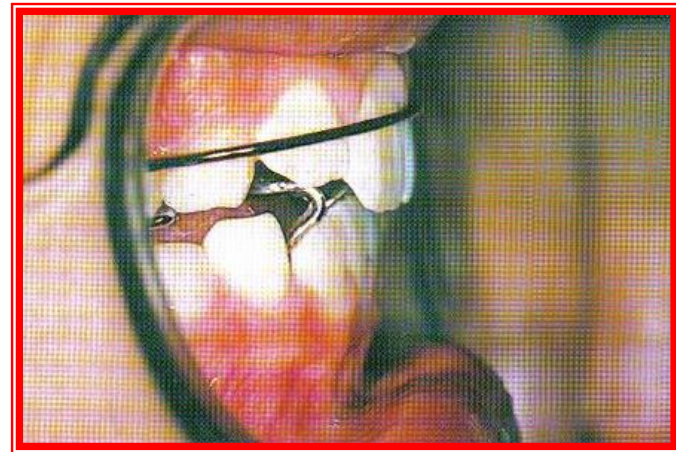
INDICACIONES

- ◉ Hipodivergencia, sobremordida sin resalte
- ◉ Distoclusiones con resaltes iguales o menores de 3 mm
 - ◉ Neutroclusiones
- ◉ Facilita la adaptación al uso del aparato
 - ◉ Mantener la postura en D.A.
 - ◉ Evitar fracturas parcialmente los movimientos de lateralidad

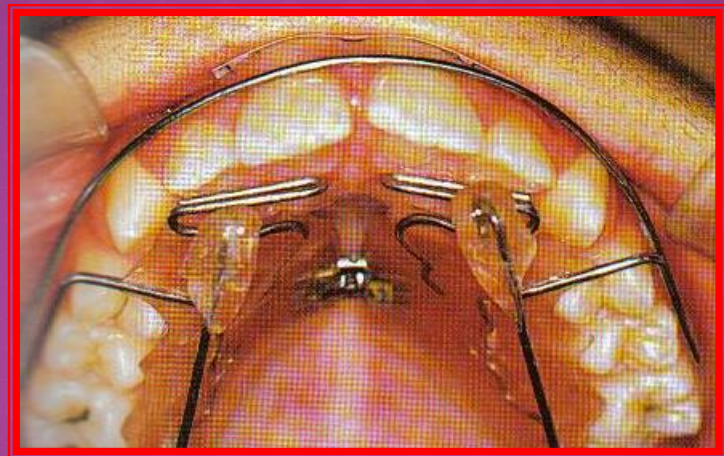


CONTRAINDICACIONES

- ◉ Mesoclusión
- ◉ Tendencia a progenie
- ◉ Borde a borde



(SN 9)
ARCOS DORSALES
LIBRES



INDICACIONES

- ◉ Cambio de postura terapéutica en 2 etapas
 - ◉ Distoclusiones menores de 5mm
 - ◉ Distoclusiones con protrusión
 - ◉ Neutroclusiones
- ◉ Estimular movimientos lateroprotrusivos
- ◉ Obtención del contacto incisivo en D.A.
 - ◉ Ampliar el espacio orofuncional
 - ◉ Facilita la adaptación del aparato
- ◉ Modificar y controlar la postura labial



CONTRAINDICACIONES

- ◉ Mesiocclusiones
- ◉ Tendencia de progenie o borde a borde

ELEMENTOS

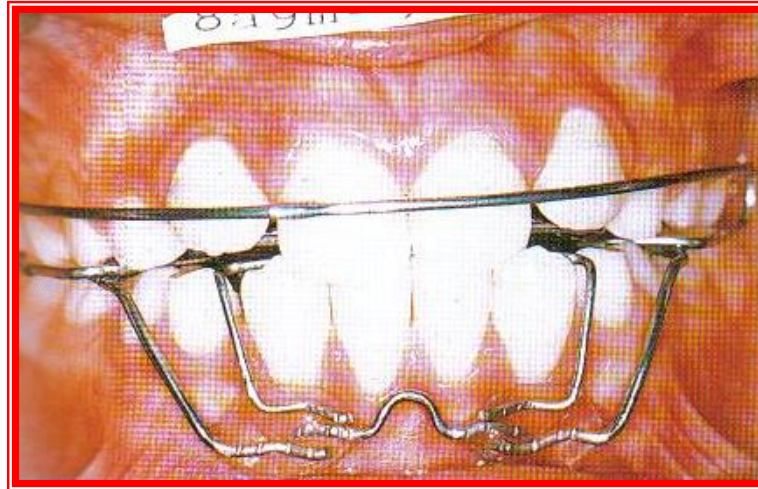
- ◉ Con arcos dorsales en la parte anterior
- ◉ Pequeños apoyos enacrílico a nivel de incisivos laterales caninos y primeros premolares

(SN 10)
MODELOS DE ESCUDOS
LABIALES. CORBATA



INDICACIONES

- ◉ Distoclusiones discretas con resaltes menores de 5mm
 - ◉ Neutroclusiones
- ◉ Obtención del contacto incisivo en D.A.
 - ◉ Estimular el cierre
 - ◉ Anclaje mandibular
 - ◉ Protrusión corta
- ◉ Ampliar el espacio oral funcional
- ◉ Orientar la posición sagital de la mandíbula
- ◉ Orientar y liberar la migración mesial de los dientes inferiores posteriores
 - ◉ Modificar y controlar la postura labial



CONTRAINDICACIONES

- ◉ Mesiocclusiones
- ◉ Tendencia de progenie o borde a borde

ELEMENTOS

- ◉ Escudos labiales de 5mm de altura y 2mm de espesor
- ◉ Bases acrílicas

(SN 11)
ALETAS VERTICALES



INDICACIONES

- ◉ Rotación frontal vertical
- ◉ Anclaje mandibular unilateral
- ◉ Obtención del contacto incisivo en D.A.
- ◉ Orientar la posición sagital de la mandíbula
 - ◉ Estimular el cierre
- ◉ Mordidas cruzadas unilaterales o bilaterales





INDICACIONES

- ◉ Hábitos parafuncionales relativos a la lengua
 - ◉ Distoclusiones
 - ◉ Neutroclusiones
- ◉ Aliviar o eliminar síntomas articulares por malposcionamiento mandibular

ELEMENTOS

- ◉ Aleta vertical unilateral o bilateral
 - ◉ Base acrílica